

MID-60

Багатовимірний опитувальник дисоціації (60 пунктів)

Клінічний гід для лікаря

Конспект OSF Technical Paper

Цей документ — клінічний дайджест технічного паперу Kate & Hegarty (2026) українською мовою, для практичних потреб українськомовних психіатрів, психотерапевтів і клінічних психологів. Усі дані щодо підрахунку, перцентилів, межі клінічної значущості, 16-категорійної класифікації та інтерпретативні параграфи — дослівно з оригінального документа, перекладені й узгоджені з термінологією DSM-5-TR і МКХ-10.

Версія документа: 0.985

Дата: 27 травня 2026

Укладач: Віленчик А.О., MD (психіатр-нарколог, Київ)

Репозиторій: github.com/BenBakster/mid60-tools

Першоджерело: Kate, M.-A. & Hegarty, D.L. (2026). A Review of the Clinical Utility and Psychometric Properties of the Multidimensional Inventory of Dissociation — 60-item Version (MID-60): Norms, Percentile Rankings, and Qualitative Descriptors. doi:10.17605/OSF.IO/E83KC.

Ліцензія першоджерела: Open Source Licence — використовується без дозволу.

Ліцензія цього конспекту: MIT (як і решта репозиторію).

Зміст

Опис інструменту	1
Що вимірює MID-60	1
Походження від MID-218	1
Цільові клінічні застосування	1
Психометричні властивості	1
Нормативні зразки	2
Підрахунок	3
Загальний бал (Total Mean Score)	3
Перцентильні ранги	3
Дескриптори тяжкості	4
16-категорійна Probable Profile Classification	5
Логіка класифікатора	5
Ключові змінні	5
Дисоціативні розлади (категорії 1–9)	5
ПТСР (категорії 10–13)	6
Функціональний неврологічний розлад (категорії 14–15)	6
Без клінічних ознак (категорія 16)	7
12 підшкал	8
Категорії дисоціативних розладів	8
Категорії функціонального неврологічного розладу	9
Загальні підшкали (general subscales)	9
Ранжування підвищених підшкал (Composite ranking)	10
Формула композитного бала	10
Секція 1: Підшкали, що формують ймовірний профіль	10
Секція 2: Додаткові клінічно значущі симптоми	10
Пункти безпеки (Safety items)	12
Протокол реагування	12
Графіки звіту	13
Total Score Bar Chart	13
Horizontal Distribution Chart	13
Subscale Bar Chart	13
Multi-Administration Line Plot	13
Перцентильна таблиця 0–100	14
Маршрутизація до структурованої діагностики	16
Алгоритм направлення	16
Обмеження та застереження	17
MID-60 — це скринінг, а не діагноз	17
Хвіст розподілу	17
Item-level threshold — непублічна формула	17
Stigma- і culture-related	17
Джерела	19

Опис інструменту

Що вимірює MID-60

MID-60 — це 60-пунктовий скринінговий інструмент самозвіту для дорослих (18+), розроблений для оцінювання дисоціативних симптомів і переживань, які відповідають диференціальній діагностиці дисоціативних розладів за DSM-5-TR. Окрім власне дисоціативних феноменів, опитувальник захоплює суміжні явища — посттравматичні симптоми (повторні переживання), соматичні (функціональні неврологічні) симптоми та такі стани, як транс і розгубленість щодо власного Я.

Дисоціація розуміється як адаптивний захисний механізм у відповідь на високий стрес або травму, що проявляється амнезією, проблемами з пам'яттю, деперсоналізацією, дереалізацією, розгубленістю щодо ідентичності та зміною ідентичності. За даними Kate et al. (2020b), близько 10% популяції впродовж життя відповідатиме критеріям якогось із дисоціативних розладів.

Походження від MID-218

MID-60 — це коротка версія повного 218-пунктового MID Dell (2006), діагностичного інструменту. MID-60 побудовано з тих п'яти пунктів, що мали найвище факторне навантаження (pattern matrix loading) у кожному з 12 факторів повного MID (Dell & Lawson, 2009). MID-60 має майже ідентичну факторну структуру до повного MID, відмінну внутрішню узгодженість ($\alpha = .97-.98$) і добру конвергентну й контент-валідність (Kate et al., 2021a, 2021b, 2023, 2026).

Цільові клінічні застосування

Загальний бал MID-60 — це відсоток часу, упродовж якого респондент самозвітом переживає дисоціативні симптоми. Підшкальні бали дозволяють лікареві формувати імпресію про ймовірну діагностичну категорію:

- Підвищені **Flashbacks** і **DeperDereal** — у бік дисоціативного підтипу ПТСР;
- Підвищена **Amnesia (for recent events)** у поєднанні з ідентичнісними підшкалами (**AlterPerson**, **AngryIntrusion**, **PersecIntrusion**) — у бік ДПІ;
- **Body Symptoms** і **Seizures** — у бік функціонального неврологічного розладу (конверсійного).

Інструмент особливо цінний у виявленні осіб, які потребують структурованої діагностики через SCID-D, DDIS або TADS-I. Враховуючи те, що дисоціативні симптоми часто помилково атрибутують біполярному розладу або психозу (Moskowitz et al., 2023), MID-60 допомагає не пропустити дисоціативну презентацію.

Психометричні властивості

Параметр	Значення
Внутрішня узгодженість	$\alpha = .97-.98$ (Kate et al., 2021a)
Контент-валідність	Висока — пункти з найвищим pattern matrix loading у відповідних факторах
Конвергентна валідність	Підтверджено Kate et al. (2021a, 2021b, 2023, 2026)
Факторна структура	Майже ідентична повному MID-218 (12 факторів)

Параметр	Значення
Тестовий час	≈ 30 секунд-5 хвилин на пункт; повний тест ≈ 10-15 хв
Шкала відповіді	Лікертова 0-10: 0 = «ніколи», 10 = «завжди»

Нормативні зразки

Спільнотний зразок (community) — об'єднання австралійської університетської вибірки (n=313; M=13.0, SD=13.8; Kate et al., 2021a) та британської загальнонаціональної вибірки (n=701; M=12.9, SD=13.1; McRoberts, 2025). Об'єднаний M=12.94, SD=13.32, n=1014. Дисоціація найвища серед молодих (18-20 років) і знижується з віком; найнижчі медіани — у віковій групі 75-84 (Kate et al., 2026).

Клінічний зразок (clinical) — клієнти NovoPsych з діагностованими дисоціативними розладами. У жінок з ДПІ (N=30) M=56.8, SD=18.8 (Kate, Jamieson & Middleton, 2023). Це узгоджується з даними для повного MID-218 — ДПІ (N=76, M=51.3, SD=18.7) та OSDD-1 (N=40, M=39, SD=19.4; Dell et al., 2017). У ширшому клінічному пулі (n=8401 жінки + n=2834 чоловіки) середні бали не відрізняються статистично за статтю (M=25.5 vs 24.6), але клієнти, заcodedовані як non-binary/other (n=339), мають помітно вищі бали (M=37.2) — частково через молодший вік.

Підрахунок

Загальний бал (Total Mean Score)

Загальний середній бал розраховується як середнє арифметичне всіх 60 відповідей, помножене на 10:

$$\text{Total} = \left(\frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} r_i \right) \times 10$$

де $r_i \in [0, 10]$ — відповідь на пункт i . Діапазон загального балу — 0–100.

Інтерпретаційно цей бал представляє **відсоток часу**, протягом якого пацієнт самозвітом переживає дисоціативні симптоми та явища.

Перцентильні ранги

Перцентильні ранги обчислюються через функцію розподілу стандартного нормального розподілу (CDF), припускаючи нормальність MID-60 загальних середніх балів у межах кожної референтної популяції:

$$P = \Phi(z) \times 100, \quad \text{де } z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Використовуються два референтні зразки:

Популяція	μ	σ	n
Спільнотний (community)	12.94	13.32	1014
Клінічний (ДПІ)	56.8	18.8	30

Інтерпретація перцентилів:

- Спільнотний перцентиль 50 — середній (здоровий) рівень дисоціативного досвіду.
- Спільнотний перцентиль 90+ — клінічно значущий рівень.
- Клінічний перцентиль 50 — рівень патологічної дисоціації, типовий для комплексних дисоціативних розладів (зокрема ДПІ).

Застереження щодо хвоста розподілу. Цей підхід припускає приблизну нормальність у межах кожного референтного розподілу. Враховуючи відомий позитивний скос розподілу дисоціативних симптомів у спільнотних зразках (Kate et al., 2020b), перцентильні оцінки у верхньому хвості спільнотного розподілу слід інтерпретувати з обережністю.

Дескриптори тяжкості

OSF-документ оперує 8-рівневою шкалою якісних дескрипторів загального балу. Кожен рівень містить діагностичні гіпотези, які варто верифікувати клінічним інтерв'ю.

Діапазон	Дескриптор	Інтерпретація
0-6	Немає	Не має дисоціативних переживань
7-14	Мінімальна	Має небагато діагностично значущих дисоціативних переживань
15-20	Легка	Легкі дисоціативні симптоми та переживання. Можливі ПТСР або легкий дисоціативний розлад (наприклад, дисоціативна амнезія, розлад деперсоналізації/дереалізації)
21-30	Помірна	Імовірний дисоціативний розлад та/або ПТСР
31-40	Помірно-висока	Імовірний дисоціативний розлад (наприклад, OSDD-1 або ДРІ) з супутнім ПТСР
41-63	Висока	Імовірно, наявний ДРІ або тяжкий дисоціативний розлад із супутнім ПТСР
64-79	Тяжка	Тяжкі дисоціативні та посттравматичні симптоми. Особи з ДРІ часто потрапляють у цей діапазон. Утім, високі бали можуть також відображати невротизм, привертання уваги, перебільшення чи симуляцію симптомів або психоз
80-100	Надзвичайно тяжка	Свідчить про надзвичайно високий бал — навіть серед осіб з діагностованими тяжкими та комплексними дисоціативними розладами

16-категорійна Probable Profile Classification

Логіка класифікатора

MID-60 використовує 16-категорійну систему ймовірної діагностичної класифікації, побудовану на апіорних правилах (Kate, 2025). Респондент призначається до **першої категорії, чиї критерії задовольняються**; категорії оцінюються ієрархічно в порядку **спадної клінічної тяжкості**. Алгоритм враховує загальну тяжкість MID-60, специфічні підвищення підшкал у клінічному діапазоні та патерни співіснування симптомів.

Категорії організовані у **чотири діагностичні родини**:

- **Дисоціативні розлади** (категорії 1-9) — DPI, OSDD-1, варіанти дисоціативної амнезії, дисоціативний підтип ПТСР і розлад деперсоналізації/дереалізації.
- **ПТСР** (категорії 10-13) — травматичні презентації з різною комбінацією дисоціативних та функціональних неврологічних ознак.
- **Функціональний неврологічний розлад** (категорії 14-15) — конверсійні презентації з дисоціативними ознаками або без них.
- **Без клінічних ознак** (категорія 16) — дисоціативного розладу не виявлено.

Ключові змінні

Змінна	Визначення
Identity Count (кількість ідентичнісних)	Скільки з трьох підшкал — AlterPerson , AngryIntrusion , PersecIntrusion — у клінічному діапазоні (0-3)
Dissociation-Relevant (дисоціативно-релевантні)	Чи хоч одна з: AlterPerson , AngryIntrusion , PersecIntrusion , DeperDereal , AutoMemory , Amnesia — у клінічному діапазоні
OCSO Criteria Met (критерії інших клінічно значущих дисоціативних симптомів)	Total ≥ 15 I хоч одна dissociation-relevant у клінічному діапазоні
Has Conversion (наявність конверсії)	Seizures або BodySymptoms у клінічному діапазоні

Дисоціативні розлади (категорії 1-9)

Ця родина оцінюється першою; її критерії обмежені порогоми загальної тяжкості MID-60.

#	Профіль	Критерії
1	Дисоціативний розлад ідентичності (DPI)	Total ≥ 21 I Amnesia@cutoff I ≥ 2 ідентичнісні підшкали@cutoff
2	Інший уточнений дисоціативний розлад (OSDD-1)	Amnesia НЕ у клінічному діапазоні I одне з: (a) Total ≥ 31 I ≥ 1 ідентичнісна підшкала@cutoff, АБО (b) Total ≥ 21

#	Профіль	Критерії
		I AlterPerson@cutoff I (AngryIntrusion АБО PersecIntrusion)@cutoff
3	Дисоціативний підтип ПТСР з ДА (дПТСР + ДА)	Total ≥ 15 I Flashbacks@cutoff I DeperDereal@cutoff I AutoMemory@cutoff
4	ДА з ДП/ДР (ДА + ДП/ДР)	Total ≥ 15 I AutoMemory@cutoff I DeperDereal@cutoff I Flashbacks HE@cutoff
5	ДА з ПТСР (ДА + ПТСР)	Total ≥ 15 I AutoMemory@cutoff I Flashbacks@cutoff I DeperDereal HE@cutoff
6	Дисоціативна амнезія (ДА only)	Total ≥ 15 I AutoMemory@cutoff I Flashbacks HE I DeperDereal HE
7	Дисоціативний підтип ПТСР (дПТСР)	Total ≥ 15 I Flashbacks@cutoff I DeperDereal@cutoff I AutoMemory HE@cutoff
8	Розлад деперсоналізації/дереалізації (ДП/ДР)	Total ≥ 15 I DeperDereal@cutoff I Flashbacks HE I AutoMemory HE
9	Інші клінічно значущі дисоціативні симптоми (ІКЗДС, OCSD)	Total ≥ 15 I ≥1 dissociation-relevant@cutoff I Flashbacks HE@cutoff I HE Has Conversion

ПТСР (категорії 10-13)

Не обмежені порогом Total — оцінюються після того, як категорії 1-9 не пройшли.

#	Профіль	Критерії
10	ПТСР + ІКЗДС	Flashbacks@cutoff I OCSD Criteria Met I HE Has Conversion
11	ПТСР + конверсія + ІКЗДС	Flashbacks@cutoff I OCSD Criteria Met I Has Conversion
12	ПТСР + конверсія	Flashbacks@cutoff I Has Conversion I OCSD Criteria НЕ Met
13	ПТСР	Flashbacks@cutoff I DeperDereal HE I AutoMemory HE I HE Has Conversion I OCSD HE Met

Функціональний неврологічний розлад (категорії 14-15)

#	Профіль	Критерії
14	ФНР + ІКЗДС	Has Conversion I OCSD Criteria Met I Flashbacks HE@cutoff
15	Функціональний неврологічний розлад	Has Conversion I жодна dissociation-relevant HE@cutoff I Flashbacks HE@cutoff

Без клінічних ознак (категорія 16)

#	Профіль	Критерії
16	Дисоціативного розладу не виявлено	Жоден з вищеперелічених критеріїв не задоволено

Клінічна примітка. Ймовірний профіль — це **гіпотеза для верифікації**, а не діагноз. Хоча алгоритм Kate (2025) ієрархічно враховує тяжкість і паттерн підшкал, остаточна категоризація потребує клінічного інтерв'ю (SCID-D / DDIS / TADS-I) та виключення інших причин підвищення підшкал (травма голови, СДУГ, психоз, симуляція).

12 підшкал

MID-60 містить 12 підшкал. Кожна підшкала має визначений набір пунктів (від 1 до 8) і клінічну межу (cutoff) на бал підшкали від 0 до 100. Підшкала вважається у **клінічному діапазоні**, коли її середній бал $\times 10 \geq \text{cutoff}$.

Категорії дисоціативних розладів

1. Amnesia (for recent events) — Дисоціативна амнезія за поточні події

Пункти: 42, 45, 48, 58. **Cutoff:** 10. **Належить до:** ДПІ.

Оцінює епізоди «втраченого часу», коли пацієнт раптом опиняється у несподіваному місці, виявляє незрозумілі зміни в зовнішності або «отямлюється» з предметами в руках, не пам'ятаючи, як вони туди потрапили.

Зауваження: пункт 58 — **safety item** (див. розділ «Пункти безпеки»).

2. AlterPerson — Альтер-особистості та стани Я

Пункти: 3, 36, 39, 49, 57. **Cutoff:** 20. **Належить до:** ДПІ / OSDD-1.

Оцінює усвідомлення окремих особистісних станів або «частин» з власною ідентичністю, голосами та перспективами; зокрема — чуття дитячих голосів усередині й відчуття присутності інших осіб, які можуть говорити або перебирати контроль.

3. AngryIntrusion — Інтрузії гніву

Пункти: 28, 33, 35, 46, 60. **Cutoff:** 18. **Належить до:** ДПІ / OSDD-1.

Оцінює інтрузії гніву, які відчуються поза контролем, зокрема слова чи дії, яких пацієнт не пам'ятає після того, як заспокоївся.

4. PersecIntrusion — Переслідувальні голоси

Пункти: 22, 37, 44, 56, 59. **Cutoff:** 18. **Належить до:** ДПІ / OSDD-1.

Оцінює критичні, ворожі або саморуйнівні внутрішні голоси, які принижують, наказують завдати собі шкоди або висловлюють бажання, щоб пацієнт помер.

Зауваження: пункти 22 і 44 — **safety items** (див. розділ «Пункти безпеки»).

5. DeperDereal — Деперсоналізація / Дерееалізація

Пункти: 2, 7, 9, 13, 25, 47, 50, 53. **Cutoff:** 20. **Належить до:** розлад ДП/ДР.

Оцінює переживання нереальності щодо себе, інших або навколишнього, зокрема відокремленість від тіла чи емоцій і сприйняття світу як туманного чи далекого.

6. DistressMemory — Дистрес через проблеми з пам'яттю

Пункти: 1, 8, 20, 38, 43, 52. **Cutoff:** 30. **Належить до:** дисоціативна амнезія.

Оцінює суб'єктивний дистрес через поширені труднощі пам'яті, які впливають на повсякденне функціонування.

Confound: цю підшкалу слід інтерпретувати обережно — вона може бути підвищена через гіперактивацію / гіпоактивацію (зокрема транс), неуважність (СДУГ), черепно-мозкову травму, інші органічні причини, а в міжособистісних контекстах — через соціальну тривогу або сором.

7. AutoMemory — Втрата автобіографічної пам'яті

Пункти: 16, 19, 24, 29, 34. **Cutoff:** 34. **Належить до:** дисоціативна амнезія.

Оцінює суттєві прогалини в особистій історії, зокрема зниклі періоди дитинства або відчуття, що важливі події відбулися, але не можуть бути згадані.

8. Flashbacks — Повторні переживання

Пункти: 4, 15, 31, 40, 54. **Cutoff:** 16. **Належить до:** ПТСР.

Оцінює інтрузивне повторне проживання травматичних спогадів із яскравими сенсорними деталями.

Категорії функціонального неврологічного розладу

9. BodySymptoms — Тілесні (функціональні неврологічні) симптоми

Пункти: 5, 10, 14, 18. **Cutoff:** 10. **Належить до:** ФНР (конверсійний).

Оцінює епізоди неврологічних симптомів без медичного пояснення — тимчасову сліпоту, глухоту, параліч, труднощі з ковтанням.

10. Seizures — Психогенні неепілептичні напади (PNES)

Пункт: 26. **Cutoff:** 10. **Належить до:** ФНР (конверсійний).

Оцінює судомоподібні епізоди, які за результатами медичного обстеження не мають епілептичної природи. Часто виникають у контексті травматичного анамнезу.

Загальні підшкали (general subscales)

11. Trance — Транс

Пункти: 21, 27, 30, 32, 41, 51. **Cutoff:** 11.7. **Належить до:** general.

Оцінює тривалі стани трансу з вираженим зниженням усвідомлення оточення та відірваністю від теперішньої реальності.

Confound: транс — **неспецифічний** симптом. Включає фантазування, мрії, «highway hypnosis», глибоку зосередженість на завданні. Підвищення на цій підшкалі без інших дисоціативно-релевантних підшкал у клінічному діапазоні не варто інтерпретувати як патологічну дисоціацію.

12. SelfConfusion — Розгубленість щодо власного Я

Пункти: 6, 11, 12, 17, 23, 55. **Cutoff:** 33.3. **Належить до:** general.

Оцінює глибоку невпевненість щодо власної ідентичності — хто я насправді, неспроможність утримати когерентне відчуття себе.

Confound: розгубленість щодо Я може виникати в інших ідентичнісних контекстах (BPD, підлітковий вік, важливі екзистенційні переходи) — її варто розглядати разом із підвищеннями на інших дисоціативних підшкалах.

Ранжування підвищених підшкал (Composite ranking)

Коли кілька підшкал у клінічному діапазоні, лікареві важливо швидко зорієнтуватися, **яка** з них найбільш клінічно значуща. OSF-документ пропонує композитний бал, який порівню зважує дві характеристики:

- **Severity (тяжкість)** — пропорційне перевищення клінічної межі: $\frac{\text{Score} - \text{Cutoff}}{\text{Cutoff}}$.
- **Breadth (широта)** — частка пунктів усередині підшкали, які перевищують свій **item-level** клінічний поріг.

Формула композитного бала

$$\text{Composite} = 0.5 \times \text{Proportional Excess} + 0.5 \times \text{Item Clinical Proportion}$$

де:

$$\text{Proportional Excess} = \frac{\text{Score} - \text{Cutoff}}{\text{Cutoff}}$$

$$\text{Item Clinical Proportion} = \frac{N_{\text{items at threshold}}}{N_{\text{total items in subscale}}}$$

Підвищені підшкали в звіті MID-60 поділяються на дві секції — обидві сортовані за composite по спаданню:

Секція 1: Підшкали, що формують ймовірний профіль

Відображається, коли (а) встановлено ймовірний дисоціативний розлад I (b) є підвищені підшкали, концептуально пов'язані з цим профілем. Кожен з 16 профілів має визначений набір «своїх» підшкал. Наприклад:

Профіль	«Свої» підшкали
ДPI (1)	Amnesia, AlterPerson, AngryIntrusion, PersecIntrusion
OSDD-1 (2)	AlterPerson, AngryIntrusion, PersecIntrusion
дПТСТ + ДА (3)	Flashbacks, DeperDereal, AutoMemory
Розлад ДП/ДР (8)	DeperDereal
ІКЗДС (9)	AlterPerson, AngryIntrusion, PersecIntrusion, DeperDereal, AutoMemory, Amnesia
ПТСТ (10-13)	Flashbacks
ФНР (14-15)	(порожньо — без «своїх»)

У цій секції відображається максимум 4 підшкали.

Секція 2: Додаткові клінічно значущі симптоми

Відображає підвищені підшкали, що **не** належать до концептуально-релевантних для встановленого профілю. Ця секція з'являється навіть тоді, коли дисоціативний розлад не індикуваний (наприклад, у респондента «Без клінічних ознак», але підвищений Transe — він піде сюди для уваги клініциста).

У цій секції відображається максимум 3 підшкали.

Чому саме composite, а не тільки Score - Cutoff? Підшкали MID-60 мають різні cutoff'и (від 10 до 34) і різну кількість пунктів (від 1 до 8), тому абсолютне перевищення непорівнянне між підшкалами. Композитна формула нормалізує: 0.5 — питання «на скільки відсотків над межею», 0.5 — питання «скільки пунктів зробили внесок». Це дає симетричну, відносну метрику клінічної значущості.

Пункти безпеки (Safety items)

Три пункти MID-60 окремо оцінюють ризик самопошкодження та суїцидальної ідеї. Ці пункти оцінюються **незалежно** від підрахунку підшкал і автоматично позначаються щоразу, коли респондент дає на них відповідь **вище нуля** (тобто response ≥ 1 , від 1/10 і більше).

Пункт	Підшкала	Текст (UK)
22	PersecIntrusion	Ви чуєте голос у своїй голові, який хоче, щоб ви зробили собі боляче
44	PersecIntrusion	Ви чуєте голос у своїй голові, який хоче, щоб ви померли
58	Amnesia	Бували випадки, коли ви «прокидалися» й знаходили у своїй руці таблетки чи лезо (або щось інше, чим можна заподіяти собі шкоду) у своїй руці

Протокол реагування

Коли спрацював хоча б один safety item:

1. **Пряма оцінка суїцидальних думок** — за C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale) або клінічним протоколом установи. Питання щодо ідеї, плану, наміру, доступу до засобу, попередніх спроб.
2. **Інформована згода на контакт із близькими** — окреслити з пацієнтом, кого можна залучити (партнер, родич, друг) і за яких умов.
3. **Ескалація залежно від ризику:**
 - **Низький ризик** — амбулаторне ведення, психотерапія, моніторинг.
 - **Середній ризик** — інтенсивне амбулаторне ведення, контакт з близькими, обмеження доступу до засобів самоушкодження (засоби gun safety / blade safety / medication safety), додаткова консультація.
 - **Високий ризик / гострий план** — стаціонарна допомога, при відмові — рішення про недобровільну госпіталізацію відповідно до ст. 14 Закону України «Про психіатричну допомогу».
4. **Документація** — у медичній картці зафіксувати: спрацьовані safety items з балом, результат C-SSRS, обговорені альтернативи, обраний план, контактний номер.

Інтерпретативний шаблон OSF. У звіті MID-60 при спрацюванні хоч одного safety item виводиться попередження: **«Ризик самопошкодження або суїциду:** Респондент вказав на ризик самопошкодження або суїциду на основі таких пунктів: [список]. Рекомендується дотримуватися протоколу оцінки суїцидального ризику для визначення характеру, тяжкості та невідкладності ризику.» Це попередження — **не діагноз**, а сигнал «не пропустити» в межах скринінгу.

Графіки звіту

При **першому** проходженні MID-60 у звіті відображаються три візуалізації:

Total Score Bar Chart

Загальний середній бал як вертикальна стовпчикова шкала на тлі кольорово-кодованих діапазонів дескрипторів тяжкості (від «Немає» до «Надзвичайно тяжка»). Дає миттєву візуальну оцінку тяжкості.

Horizontal Distribution Chart

Загальний бал у **порівнянні з двома популяціями**: спільнотний (community, зелений) і клінічний з комплексними дисоціативними розладами (синій). Відображаються 25-й і 75-й перцентилі (interquartile range) як горизонтальні смуги та медіани як маркери. Діапазони дескрипторів — на нижній осі. Допомагає клініцистові вирішити: «бал ближче до типового досвіду або до патологічного?»

Subscale Bar Chart

Усі 12 середніх балів підшкал як горизонтальні стовпчики, з затіненими ділянками, що позначають клінічний діапазон для кожної підшкали. Дозволяє швидко ідентифікувати, які домени симптомів підвищені й потребують уваги.

Multi-Administration Line Plot

При **повторних** проходженнях MID-60 перші два графіки замінюються на лінійний графік: загальний середній бал у часі з фоновими діапазонами дескрипторів. Допомагає відстежити прогрес або погіршення. Subscale Bar Chart продовжує відображатися для найсвіжішого проходження.

Перцентильна таблиця 0-100

Повна таблиця перцентилів для всіх можливих значень загального середнього бала (0–100), розрахована за CDF нормального розподілу з $\mu_{\text{комм.}} = 12.94$, $\sigma_{\text{комм.}} = 13.32$ та $\mu_{\text{клін.}} = 56.8$, $\sigma_{\text{клін.}} = 18.8$.

Бал	Комм. %	Клін. %
0	17	0.13
1	19	0.15
2	21	0.18
3	23	0.21
4	26	0.25
5	28	0.29
6	31	0.34
7	33	0.4
8	36	0.47
9	39	0.55
10	41	0.6
11	44	0.7
12	47	0.9
13	50	1.0
14	53	1.1
15	56	1.3
16	59	1.5
17	61	1.7
18	64	2.0
19	67	2.2
20	69	2.5
21	72	2.8
22	74	3.0
23	77	3.6
24	79	4.0
25	81	4.5
26	83	5.0
27	84	5.6
28	86	6.0
29	88	7.0
30	89	7.7
31	90	8.0
32	92	9.0
33	93	10
34	94	11
35	94.5	12
36	95	13
37	96	15
38	96.5	16
39	97	17
40	97.5	19
41	98	20
42	98.2	22

Бал	Комм. %	Клін. %
43	98.5	23
44	98.8	25
45	99	27
46	99.2	28
47	99.3	30
48	99.4	32
49	99.5	34
50	99.6	36

Бал	Комм. %	Клін. %
51	99.7	38
52	99.8	40
53	99.8	42
54	99.85	44
55	99.88	46
56	99.91	48
57	99.93	50
58	99.94	53
59	99.96	55
60	99.97	57
61	99.97	59
62	99.98	61
63	99.99	63
64	99.99	65
65	99.99	67
66	99.99	69
67	99.99	71
68	99.99	72
69	99.99	74
70	99.99	76
71	99.99	77
72	99.99	79
73	99.99	81
74	99.99	82
75	99.99	83
76	99.99	85
77	99.99	86
78	99.99	87
79	99.99	88
80	99.99	89
81	99.99	90
82	99.99	91
83	99.99	92
84	99.99	93
85	99.99	93
86	99.99	94
87	99.99	95
88	99.99	95.1
89	99.99	95.7
90	99.99	96.1
91	99.99	96.6
92	99.99	96.9
93	99.99	97.3
94	99.99	97.6
95	99.99	97.9
96	99.99	98.1
97	99.99	98.4
98	99.99	98.6

Бал	Комм. %	Клін. %
99	99.99	98.8
100	99.99	98.9

Маршрутизація до структурованої діагностики

MID-60 — **скринінговий** інструмент. Він не призначений як єдина основа для діагнозу; його завжди слід інтерпретувати в поєднанні з клінічним інтерв'ю. Коли є клінічно значущі підвищення, OSF-документ рекомендує верифікувати через одне з наступних структурованих інтерв'ю:

Інструмент	Опис і автор
SCID-D	Structured Clinical Interview for DSM-5 Dissociative Disorders. Marlene Steinberg, MD. Золотий стандарт для DSM-5 дисоціативних розладів. ≈ 60–120 хв.
DDIS	Dissociative Disorders Interview Schedule. Colin Ross, MD. Альтернативне структуроване інтерв'ю, охоплює також супутні розлади (BPD, депресія, ПТСР).
TADS-I	Trauma and Dissociative Symptoms Interview. Suzette Boon. Детально оцінює травматичні переживання та дисоціативні симптоми у клінічних популяціях.

Алгоритм направлення

При підвищенні ідентичнісних підшкал (AlterPerson + AngryIntrusion / PersecIntrusion) + Amnesia → пріоритетно **SCID-D** для верифікації DPI / OSDD-1. При переважно функціональних неврологічних симптомах — **неврологічне обстеження** з виключенням органічної патології до атрибуції дисоціативному розладу. При підвищенні Flashbacks без ідентичнісних — **CAPS-5** або **PCL-5** для верифікації ПТСР.

Обмеження та застереження

MID-60 — це скринінг, а не діагноз

Підвищення на MID-60 — **показник для подальшої клінічної оцінки**, а не діагностичне рішення. Можливі альтернативні пояснення підвищень:

Альтернатива	Якщо підвищені
Шизофренія / шизоафективний	Псевдогалюцинації (PersecIntrusion), розгубленість Я. Розрізнення: First Rank Symptoms vs відчуття «не я» (дисоціативні мають ego-aliené якості)
Біполярний розлад	DistressMemory у фазі манії; деперсоналізація при змішаних епізодах. Розрізнення: афективна циклічність
BPD (межовий)	SelfConfusion, AngryIntrusion. Розрізнення: інтерперсональні тригери; нестабільність Я BPD не має «не я» якості
СДУГ	DistressMemory через неувважність; Trance як «розфокус». Розрізнення: anamnesis з дитинства, респонденти різного фокусу
ЧМТ / органіка	DistressMemory, AutoMemory. Виключити через нейро-обстеження + анамнез
Симуляція / перебільшення	Високі бали (64-79+) без життєвої дисфункції, що відповідала би тяжкості. Розрізнення: collateral cor-сі, перевірка послідовності
Психоз без афективного фону	Слухові інтрузії (PersecIntrusion) як commenting voices. Розрізнення: відсутність «частин», збереження reality testing у разі дисоціації

Хвіст розподілу

Перцентилі у верхньому хвості спільнотного розподілу базуються на нормальному наближенні, тоді як реальний розподіл має позитивний скос. Тому, наприклад, спільнотний перцентиль «99.99%» для балу 64+ — це формальний розрахунок, не емпірична оцінка. Інтерпретувати з обережністю.

Item-level threshold — непублічна формула

OSF-документ описує існування **item-level clinical thresholds** (для підрахунку breadth-компоненти composite), але не публікує точної формули їх обчислення. У mid60-engine.js цього інструменту item зараховується до клінічного діапазону, коли його raw response $\times 10 \geq$ subscale cutoff. Це узгоджується з 8 з 12 підшкал OSF Sample Report; розходження у ± 1 item впливає лише на composite-ранжування, не на atCutoff і не на класифікацію.

Stigma- і culture-related

Для українськомовних пацієнтів варто звернути увагу на культурально-чутливе формулювання. Поняття «голоси» (PersecIntrusion) у пацієнтів з релігійним або народним

досвідом може мати інтерпретацію через духовну рамку — це не виключає дисоціації, але вимагає тонкого розслідування контексту переживання.

Джерела

Першоджерело цього конспекту:

Kate, M.-A. & Hegarty, D. L. (2026). A Review of the Clinical Utility and Psychometric Properties of the Multidimensional Inventory of Dissociation — 60-item Version (MID-60): Norms, Percentile Rankings, and Qualitative Descriptors. doi:10.17605/OSF.IO/E83KC.

Розробка MID-60:

Kate, M.-A., Jamieson, G., Dorahy, M. J., & Middleton, W. (2020 / 2021a). Measuring Dissociative Symptoms and Experiences in an Australian College Sample Using a Short Version of the Multidimensional Inventory of Dissociation. **Journal of Trauma & Dissociation**, 22(3), 265–287. doi:10.1080/15299732.2020.1792024.

Повний MID (218 пунктів) і його інтерпретативний посібник:

Dell, P. F. (2006). The Multidimensional Inventory of Dissociation (MID): A Comprehensive measure of pathological dissociation. **Journal of Trauma & Dissociation**, 7(2), 77–106.

Dell, P. F., Coy, D. M., & Madere, J. (2017). **An Interpretive Manual for the Multidimensional Inventory of Dissociation (MID)** (2nd ed.). mid-assessment.com.

Поширеність дисоціативних розладів:

Kate, M.-A., Hopwood, T., & Jamieson, G. (2020b). The prevalence of Dissociative Disorders and dissociative experiences in college populations: a meta-analysis of 98 studies. **Journal of Trauma & Dissociation**, 21(1), 16–61.

Травма як предиктор дисоціації:

Kate, M.-A., Jamieson, G., & Middleton, W. (2021b). Childhood Sexual, Emotional, and Physical Abuse as Predictors of Dissociation in Adulthood. **Journal of Child Sexual Abuse**, 1–24.

Kate, M.-A., Jamieson, G., & Middleton, W. (2023). Parent-child dynamics as predictors of dissociation in adulthood. **European Journal of Trauma & Dissociation**, 7(1), Article 100312.

Клінічна валідація MID-60:

Kate, M.-A., Swinfield, H., Hegarty, D. L., Buchanan, B., & Dorahy, M. J. (2026 manuscript under review). **Validation of the Multidimensional Inventory of Dissociation-60 items (MID-60) in a clinical population.**

Диференціація з психозом і BPD:

Korzekwa, M. I., Dell, P. F., Links, P. S., Thabane, L., & Fougere, P. (2009). Dissociation in Borderline Personality Disorder: A Detailed Look. **Journal of Trauma & Dissociation**, 10(3), 346–367.

Laddis, A., & Dell, P. F. (2012). Dissociation and Psychosis in Dissociative Identity Disorder and Schizophrenia. **Journal of Trauma & Dissociation**, 13(4), 397–413.

Moskowitz, A., Longden, E., Varese, F., Mosquera, D., & Read, J. (2023). The nature of psychotic symptoms: Traumatic in origin and dissociative in kind? In M. J. Dorahy, S. N. Gold, & J. A. O’Neil (Eds.), **Dissociation and the dissociative disorders: Past, present, future** (2nd ed., pp. 513–527). Routledge.

Embodied self:

McRoberts, K. J. (2025). Examining Whether There is a Relationship Between Embodied Sense of Self and Dissociative Experiences (Unpublished Masters thesis). University of Canterbury.

Класифікаційні системи:

American Psychiatric Association. (2022). **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders** (Fifth Edition, Text Revision; DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing.

World Health Organization. (2019). **International statistical classification of diseases and related health problems** (11th ed.). icd.who.int.

Атрибуція цього конспекту. Документ укладено психіатром-наркологом А. О. Віленчиком (Київ) на основі публічно доступного OSF Technical Paper Kate & Hegarty (2026) з застосуванням української клінічної термінології, узгодженої з традицією DSM-5-TR і МКХ-10. Український переклад пройшов внутрішній лінгво-клінічний аудит (травень 2026). Документ є **неофіційним** і не проходив психометричної валідації українською мовою; для офіційних висновків використовуйте англomовну версію інструменту. Розповсюджується під ліцензією MIT як частина репозиторію BenBakster/mid60-tools.